PRÄKLINISCHES NACHSORGEPROGRAMM

Die Gegenwart schützen, die Zukunft vorbereiten

Nachsorgeprogramm für asymptomatische Träger von Mutationen im Prionprotein-Gen

Informationen über Ihre Genetik zu haben, ist ein Akt des Mutes. Diese Website ist dazu gedacht, Sie zu begleiten: Ihnen zu erklären, was es bedeutet, Träger oder Trägerin zu sein, warum regelmäßige Nachsorge ein wirksames Instrument ist, und welche Möglichkeiten die nahe Zukunft bietet

01

Ihren Ausgangspunkt verstehen

Was es bedeutet, Träger oder Trägerin zu sein

Sie sind Träger oder Trägerin einer genetischen Variante (auch Mutation genannt – eine Veränderung der DNA gegenüber der Mehrheit der Bevölkerung), die mit der Entwicklung einer erblichen Prionkrankheit assoziiert sein kann. Das bedeutet, dass ein erhöhtes Risiko besteht, keine Gewissheit. Viele Menschen mit dieser genetischen Anlage leben Jahrzehnte, ohne irgendwelche Symptome zu entwickeln, und die Wissenschaft macht rasante Fortschritte hin zu präventiven Behandlungen.

Träger oder Trägerin zu sein ist nicht dasselbe wie die Krankheit zu haben. Es ist eine Anlage, die Ihnen wertvolle Informationen gibt — und diese Informationen können, gut genutzt, zu einem echten Vorteil werden.

- **Nicht alle Träger entwickeln Symptome.** Die Penetranz — d. h. die Wahrscheinlichkeit, dass die Mutation letztendlich die Krankheit auslöst — ist hoch, obwohl das Erkrankungsalter je nach spezifischer Mutation und anderen individuellen Faktoren, die wir noch nicht kennen, erheblich variiert.

- **Wissen ist Macht.** Ihren genetischen Status zu kennen ermöglicht Ihnen, informierte Entscheidungen zu treffen, die Zukunft zu planen und auf spezialisierte Nachsorgeprogramme zuzugreifen.

- **Die Wissenschaft macht keine Pause.** Es gab noch nie so viel aktive Forschung zu Prionkrankheiten wie heute. Wir befinden uns in einem entscheidenden Moment für die Entwicklung präventiver Therapien.

02

Warum Nachsorge wichtig ist

Vier Gründe, an einem präklinischen Nachsorgeprogramm teilzunehmen

Nachsorgeprogramme für asymptomatische Träger sind nicht nur ein Instrument der Forschung und medizinischen Überwachung. Sie sind eine Plattform aktiver Vorbereitung — für Sie und für alle Menschen, die nach Ihnen kommen – angesichts der in Entwicklung befindlichen präventiven Therapien.

Früherkennung

Früherkennung: Sollten subtile biologische Veränderungen auftreten, würden diese zum günstigsten Zeitpunkt (vor dem Auftreten von Symptomen) erkannt, um mit den verfügbaren Mitteln eingreifen zu können.

Bevorzugter Zugang

Bevorzugter Zugang: Teilnehmer an Nachsorgeprogrammen wären am besten positioniert, um auf neue präventive Therapien zuzugreifen, wenn klinische Studien ihre Türen öffnen, da mehr Informationen als über andere Träger vorliegen würden.

Echte Informationen

Die regelmäßige Nachsorge liefert objektive Daten über Ihre Gehirngesundheit und ersetzt Ungewissheit durch fundiertes Wissen. Es sind Informationen, auf die Sie zugreifen oder die Sie noch nicht kennen möchten.

Kollektiver Beitrag

Ihre Teilnahme hilft dabei, die Krankheit besser zu verstehen, und beschleunigt die Entwicklung von Behandlungen für Sie und für künftige Generationen.

03

Zwei Realitäten innerhalb desselben Profils

Nicht alle asymptomatischen Träger befinden sich im gleichen Moment

Innerhalb der Gruppe der asymptomatischen Träger ermöglicht die aktuelle Forschung, zwei klar unterschiedliche Situationen zu identifizieren, obwohl in beiden Fällen die Person keine klinischen Symptome hat:

Träger/Trägerin in inaktiver Phase

Der mit der Mutation verbundene biologische Prozess zeigt mit den aktuellen Techniken keine Anzeichen nachweisbarer Aktivität. Dies ist mit einem längeren Zeithorizont vor dem möglichen Auftreten erster Symptome assoziiert.

Träger/Trägerin in stiller aktiver Phase

Es besteht eine beginnende biologische Aktivität —ohne klinische Symptome— die spezialisierte Techniken zu erkennen beginnen können. Dieses Profil ist mit einem näheren Zeithorizont assoziiert, obwohl wir noch nicht wissen, wie viel und ob es eine große Variabilität zwischen Trägern von der Erkennung biologischer Aktivität bis zur Entwicklung erster Zeichen gibt. Diese Gruppe hat jedoch die größte Wahrscheinlichkeit, auf die ersten präventiven klinischen Studien zugreifen zu können.

Herauszufinden, in welcher dieser Situationen Sie sich befinden, ist freiwillig. Das Nachsorgeprogramm bietet Ihnen die Möglichkeit, es zu erfahren — stets mit Begleitung und ohne Druck.

04

Was sich abzeichnet

Therapien in Entwicklung und erste klinische Studien

Es gab noch nie so viele gleichzeitig aktive therapeutische Strategien bei Prionkrankheiten. Mehrere haben bereits vielversprechende Ergebnisse in Tiermodellen gezeigt, und einige haben begonnen, den Sprung zu Studien mit Menschen zu wagen. Das garantiert nicht, dass alle beim Menschen funktionieren, markiert aber einen historischen Wandel: Zum ersten Mal gibt es mehrere echte Wege, die parallel auf zukünftige präventive und krankheitsmodifizierende Behandlungen hinarbeiten.

WAS JEDE SITUATION BEDEUTET

Laufende klinische Studie

Wird bereits an Menschen getestet.

Registrierte klinische Studie, Beginn ausstehend

Die Studie ist definiert und genehmigt/registriert, hat aber noch nicht mit der Rekrutierung oder Behandlung begonnen.

Präklinische Entwicklung

Die Therapie hat Aktivität im Labor und/oder bei Tieren gezeigt, wurde aber noch nicht am Menschen getestet.

Laufende klinische Studie (Phase 1/2a)

Antisense-Oligonukleotide (ASOs)

Das sind Moleküle, die dazu entwickelt wurden, die Produktion des Prionproteins zu reduzieren. In Tiermodellen hat die Senkung dieses Proteins den Krankheitsbeginn verzögert und das Überleben verlängert. Diese Strategie wird bereits in einer internationalen klinischen Studie bei Menschen mit symptomatischer Prionkrankheit bewertet.

Registrierte klinische Studie, Beginn ausstehend (Phase 1)

RNA-Interferenz (siRNA)

Diese Moleküle „schweigen" die genetische Botschaft, die zum Prionprotein führt. Bei Tieren wurden tiefe und dauerhafte Reduktionen dieses Proteins erzielt, mit positiven Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf. Zudem existiert bereits eine erste registrierte klinische Phase-1-Studie für diese Strategie, obwohl die Rekrutierung noch nicht begonnen hat.

Präklinische Entwicklung

Kleine Moleküle zur oralen Verabreichung

Es werden Verbindungen entwickelt, die in der Lage sind, die Menge des Prionproteins, die die Zelle produziert, zu reduzieren. Ihr großer potenzieller Vorteil besteht darin, dass sie als einfache, langfristige Behandlungen verabreicht werden könnten. Die bisher veröffentlichten Daten zeigen vielversprechende Ergebnisse bei Tieren, aber dieser Weg ist noch nicht in klinische Studien übergegangen.

Präklinische Entwicklung

Gentherapien

Sie umfassen Strategien zur dauerhaften Stummschaltung und molekularen Bearbeitung, die darauf ausgerichtet sind, das Prionprotein-Gen dauerhaft abzuschalten oder zu reduzieren. In Tiermodellen wurde bereits eine breite Reduktion des Proteins und eine signifikante Verlängerung des Überlebens erreicht. Einige Programme schreiten in Richtung Klinik voran, befinden sich aber derzeit noch in der präklinischen Phase.

In einem Nachsorgeprogramm eingeschrieben zu sein, bringt Sie an die erste Linie, um an diesen Studien teilzunehmen, falls sie in Spanien durchgeführt werden. Das Zeitfenster der Möglichkeiten öffnet sich — und diejenigen, die bereits in der Nachsorge sind, werden die größten Chancen haben, als Erste hindurchzugehen.

05

Was die Nachsorge umfasst

Das Protokoll regelmäßiger Besuche

Das Programm besteht aus regelmäßigen Besuchen — in der Regel jährlich oder halbjährlich — in einem spezialisierten Zentrum. Jeder Besuch ist so gestaltet, dass er so angenehm und effizient wie möglich ist, stets mit der Unterstützung eines engagierten Teams.

Neurologische und neuropsychologische Beurteilung

Detaillierte klinische Untersuchung und Batterie kognitiver Tests, um Ihren individuellen Ausgangswert zu bestimmen und zu überwachen.

Biomarker in Blut, Liquor cerebrospinalis und Haut

Blutanalyse und, wenn angezeigt, Lumbalpunktion und/oder Hautstanzbiopsie zur Messung spezifischer Proteine, die den neurobiologischen Zustand widerspiegeln.

Schlafuntersuchung

Mittels Polysomnographie erfassen wir, was während des Schlafs passiert: Bewegungen, Atmung, Hirnaktivität und Verhalten. Einige Schlafstörungen – insbesondere die mit der REM-Phase verbundenen – können besonders bei Trägern der Familiären Fatalen Insomnie auf subtile Weise auftreten, bevor die ersten Symptome erscheinen.

Hochauflösende Bildgebung

Magnetresonanztomographie des Gehirns, die es ermöglicht, strukturelle oder funktionelle Veränderungen zu erkennen, bevor sie klinisch erkennbar sind.

Psychologische Unterstützung

Emotionale Begleitung und spezialisierte Orientierung, verfügbar bei jedem Besuch und zwischen Besuchen zugänglich, wenn nötig.

Information über Neuigkeiten in der Therapie

Regelmäßige Aktualisierung über verfügbare oder in Vorbereitung befindliche klinische Studien, für die Sie möglicherweise in Frage kommen, mit personalisierter Orientierung für jede Gelegenheit.